



PROCEDIMENTO PADRÃO Nº 012

PERÍODO DE AVALIAÇÃO E CONSTRUÇÃO
DO PDI PELA EQUIPE TERAPÊUTICA

FÁBIO COELHO



SUMÁRIO

1	PERÍODO DE AVALIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PDI PELA EQUIPE TERAPÊUTICA.....	3
1.1	OBJETIVO GERAL	3
1.2	DEFINIÇÃO OPERACIONAL	3
1.3	DISPOSIÇÕES GERAIS	3
1.4	PERIODICIDADE DAS AVALIAÇÕES	4
1.5	ESTRUTURA DA INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA	4
1.5.1	EQUIPE INTERDISCIPLINAR.....	4
1.5.2	SUPERVISÃO POR ÁREA TERAPÊUTICA.....	5
1.6	ETAPAS OPERACIONAIS DO PERÍODO DE AVALIAÇÃO	5
1.7	SUGESTÕES DE PROTOCOLOS DE AVALIAÇÃO POR SUPERVISÃO DE ÁREA	6
	REFERÊNCIAS.....	8



1 **PERÍODO DE AVALIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PDI PELA EQUIPE TERAPÊUTICA**

1.1 **OBJETIVO GERAL**

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem como finalidade padronizar o período de avaliação e a construção do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) por parte da equipe terapêutica. Busca-se garantir que esse processo ocorra de maneira sistemática, com etapas observáveis e resultados mensuráveis.

1.2 **DEFINIÇÃO OPERACIONAL**

Define-se como período de avaliação e construção do PDI o conjunto de estratégias operacionais que orientam a equipe terapêutica na coleta de dados, análise de necessidades e elaboração de objetivos clínicos. Todo o processo deve ser fundamentado em evidências científicas e utilizar protocolos validados para nortear a tomada de decisões.

1.3 **DISPOSIÇÕES GERAIS**

As disposições gerais servem como diretrizes fundamentais para a condução do processo de avaliação e planejamento individualizado.

- **Base científica:** É obrigatório o uso de protocolos cientificamente validados em todas as avaliações iniciais e reavaliações.
- **Triagem inicial:** O encaminhamento do cliente à equipe terapêutica deve ser orientado por entrevistas e anamnese inicial.
- **PDI obrigatório:** Todos os clientes devem possuir um PDI ativo e atualizado, servindo como base para a intervenção terapêutica.



1.4 PERIODICIDADE DAS AVALIAÇÕES

A organização da frequência das avaliações é essencial para garantir continuidade e qualidade no acompanhamento terapêutico:

- **Avaliação inicial:** Deve ser concluída em até dois meses a partir da entrada do cliente na agenda terapêutica da equipe.
- **Reavaliações anuais:** Devem ser realizadas uma vez por ano, conforme agendamento prévio da supervisão geral da unidade.

1.5 ESTRUTURA DA INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA

A intervenção terapêutica deve ser conduzida por uma equipe interdisciplinar qualificada, sob supervisão especializada por área de atuação.

1.5.1 EQUIPE INTERDISCIPLINAR

A equipe terapêutica pode ser composta pelas seguintes especialidades:

- Psicologia.
- Psicopedagogia.
- Terapia Ocupacional.
- Fonoaudiologia.
- Fisioterapia.
- Musicoterapia.
- Nutrição.

Todos os profissionais devem possuir formação complementar em Análise do Comportamento Aplicada (ABA) e experiência prévia com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou condições associadas.



1.5.2 SUPERVISÃO POR ÁREA TERAPÊUTICA

A supervisão técnica deve abranger as seguintes áreas:

- Supervisão da Área Cognitiva.
- Supervisão da Área Psicomotora.
- Supervisão da Área Comportamental.
- Supervisão da Área Linguística.
- Supervisão da Área Funcional.
- Supervisão da Área de Terapia Baseada em Música.
- Supervisão da Área de Terapia Alimentar.

1.6 ETAPAS OPERACIONAIS DO PERÍODO DE AVALIAÇÃO

O processo de avaliação e planejamento do PDI envolve quatro etapas operacionais principais, com comportamentos observáveis e produtos específicos esperados:

- **Entrevista inicial:** A supervisão geral ou a equipe terapêutica realiza uma entrevista com o responsável, focando na escuta ativa e no estabelecimento de vínculo terapêutico. O produto gerado é o registro narrativo da entrevista.
- **Entrevista de anamnese:** A equipe coleta dados relevantes sobre o histórico do cliente, avaliações anteriores e exames médicos. O formulário de anamnese devidamente preenchido é o produto esperado.
- **Avaliação diagnóstica e de habilidades:** Os terapeutas aplicam protocolos definidos por suas respectivas áreas. Como resultado, devem produzir relatórios descritivos e analíticos das avaliações realizadas.
- **Elaboração do PDI:** Com base nos dados coletados, os terapeutas, com o acompanhamento da supervisão de área, elaboram o PDI, contendo objetivos terapêuticos mensuráveis. O produto final é o PDI completo, submetido à supervisão para validação.



1.7 SUGESTÕES DE PROTOCOLOS DE AVALIAÇÃO POR SUPERVISÃO DE ÁREA

Para orientar o processo avaliativo, seguem abaixo sugestões de protocolos validados que podem ser utilizados por cada supervisão. Ressalta-se que o Supervisor de Área tem autonomia para escolher os instrumentos mais adequados, desde que sejam validados no Brasil por seu respectivo conselho profissional.

- **Supervisão Cognitiva:**
 - Inventário Portage Operacionalizado (IPO).
 - Perfil Psicoeducacional Revisado (PEP-R).
 - Inventário de Avaliação do Repertório (IAR).
 - Assessment of Functional Living Skills (AFLS).
 - Protocolo Cognitivo-Linguístico (PCL).
 - Prova Aritmética (PA).
- **Supervisão Psicomotora:**
 - IPO.
 - Test of Gross Motor Development, 2ª edição (TGMD-2).
- **Supervisão Comportamental:**
 - Meus Progressos.
 - VB-MAPP.
 - IPO.
 - Socially Savvy.
- **Supervisão Linguística:**
 - IPO.
 - Matriz de Comunicação.
 - Avaliação do Desenvolvimento da Linguagem, 2ª edição (ADL2).
 - Protocolo de Observação Comportamental da Linguagem (PROC).
 - Teste de Linguagem Infantil nas Áreas de Fonologia, Vocabulário, Fluência e Pragmática (ABFW).



- **Supervisão Funcional:**
 - IPO.
 - Sensory Processing Measure, versão infantil e pré-escolar (SPM e SPM-P).
 - Canadian Occupational Performance Measure (COPM).
- **Supervisão Nutricional:**
 - Escala Labirinto do Comportamento Alimentar.
- **Supervisão com Música:**
 - Escala de Desenvolvimento Musical de Crianças com Autismo (Demuca).

Outros protocolos podem ser utilizados, desde que validados, respaldados por evidências científicas e reconhecidos legalmente. A decisão deve sempre considerar o contexto clínico individual e os objetivos terapêuticos traçados no PDI.

Ao seguir essas diretrizes, asseguramos não apenas a qualidade do PDI, mas também o compromisso contínuo com o desenvolvimento funcional, a autonomia e a inclusão da pessoa com TEA em diferentes contextos. Avaliar com precisão é o primeiro passo para intervir com responsabilidade e transformar realidades.



REFERÊNCIAS

BOSA, Cleonice Alves. Autismo: intervenções psicoeducacionais. **Brazilian Journal of Psychiatry**, v. 28, p. s47-s53, 2006.



EQUIPE EDITORIAL

AUTORIA

Fábio Coelho

DIAGRAMAÇÃO E DESIGN GRÁFICO

Victor Cardoso

EDIÇÃO E REVISÃO DE TEXTO

Victor Cardoso

REVISÃO TÉCNICA

Càrol Lèal

CONSULTORES E ESPECIALISTAS

Fábio Coelho

Jenifer Macedo

Maria Christina Souza

PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO

Academia do Autismo

REDES SOCIAIS



@maaisacademiadoautismo



@maaisacademiadoautismo



@academiadoautismo



@academiadoautismo

CONTATO



maais@academiadoautismo.com.br



(22) 99216-0282



academiadoautismo.com.br/maais

Este material é protegido por direitos autorais e não pode ser comercializado, distribuído, copiado, editado, alugado, transmitido ou reproduzido, total ou parcialmente, em qualquer meio de comunicação ou distribuição. Permissões para tais ações podem ser concedidas somente mediante autorização expressa do detentor e proprietário dos direitos do material. Qualquer violação dos direitos autorais estará sujeita a ações legais. Todos os direitos estão reservados à Academia do Autismo Ltda.